

Bronquiolitis

1. Introducción y relevancia clínica

La **bronquiolitis aguda** es una infección viral que afecta las **vías respiratorias inferiores** (bronquiolos) en **lactantes menores de 2 años**, produciendo **obstrucción bronquilar aguda** por edema, necrosis del epitelio y acumulación de moco.

Es la **principal causa de hospitalización pediátrica en menores de 12 meses** en Chile, especialmente durante los meses fríos (mayo a septiembre), con **picos epidémicos invernales**.

El agente causal más frecuente es el **virus respiratorio sincicial (VRS)**, responsable de hasta el **70–80 % de los casos**, aunque también pueden causar bronquiolitis otros virus: parainfluenza, metapneumovirus, adenovirus, rinovirus e influenza.

En Chile, el **MINSAL** considera la bronquiolitis como una **patología GES** y dentro del **Programa de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)**, con protocolos claros de manejo en la red asistencial.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **VRS** infecta las células epiteliales del epitelio respiratorio, principalmente de los bronquiolos terminales, causando:

- **Necrosis epitelial** y descamación.
- **Edema e infiltrado inflamatorio** submucoso.
- **Aumento de la secreción mucosa**.

Estas alteraciones provocan **obstrucción parcial o total** de los bronquiolos, generando:

- **Atrapamiento aéreo**, con hiperinflación pulmonar.
- **Alteraciones en la relación ventilación/perfusión (V/Q)**.
- **Hipoxemia** y, en casos graves, **retención de CO₂** (acidosis respiratoria).

El cuadro clínico refleja esta fisiopatología: **taquipnea, sibilancias, retracciones y dificultad respiratoria progresiva**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Cuadro clínico típico

1. **Fase inicial (catarral)** – 2–3 días:
 - Rinorrea, tos, febrícula.
 - Rechazo alimentario leve.
2. **Fase obstructiva** – 3–5 días posteriores:
 - **Taquipnea:** FR >50/min.
 - **Sibilancias espiratorias.**
 - **Retracciones subcostales o intercostales.**
 - **Aleteo nasal, quejido espiratorio.**
 - **Auscultación:** sibilancias difusas y crépitos finos.
 - **Irritabilidad o letargia.**

Duración promedio: 7–10 días (tos puede persistir 2–3 semanas).

b. Diagnóstico clínico (según MINSAL)

El diagnóstico de **bronquiolitis es clínico**, basado en:

- Primer episodio de dificultad respiratoria baja (sibilancias, retracciones).
- Menor de 2 años, especialmente <12 meses.
- Antecedente catarral previo.
- Signos de obstrucción bronquiolar al examen físico.

No se requiere radiografía ni laboratorio rutinario, salvo duda diagnóstica o gravedad.

c. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico diferencial	Elemento distintivo
Asma del lactante / sibilancias recurrentes	≥2 episodios, antecedentes familiares de atopia
Neumonía viral o bacteriana	Fiebre alta, crépitos localizados, compromiso del estado general
Cuerpo extraño	Inicio brusco, unilateral
Insuficiencia cardíaca congénita	Taquipnea persistente sin fiebre, cardiomegalia

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Exámenes rutinarios

No están indicados en casos leves ni moderados.

Solo se solicitan en:

- Dudas diagnósticas.
- Mala evolución o requerimiento de hospitalización.
- Sospecha de sobreinfección bacteriana.

Exámenes posibles:

- **Oximetría de pulso:** evaluación continua.
- **Rx de tórax:** solo si sospecha neumonía o complicación (atelectasia, hiperinsuflación).
- **Test rápido VRS / PCR respiratoria:** útil para cohortización hospitalaria, no para diagnóstico ambulatorio.

- **Gases arteriales / capilares:** si hay signos de hipoxemia o acidosis.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIPE 2024)

a. Medidas generales

El tratamiento es **de soporte**. No existen antivirales ni broncodilatadores efectivos para VRS en la mayoría de los casos.

1. Oxigenoterapia:

- Mantener $\text{SatO}_2 \geq 92\%$.
- Oxígeno por cánula nasal (1–2 L/min) o alto flujo según necesidad.
- Hospitalización si no se logra saturación adecuada.

2. Hidratación y alimentación:

- Mantener vía oral si el lactante tolera (sin taquipnea $>60/\text{min}$).
- Si no tolera → hidratación parenteral o por sonda.
- Evitar sobrehidratación (riesgo de SIADH).

3. Control térmico y confort:

- Ropa ligera, ambiente ventilado.
- Aspiración de secreciones nasales antes de alimentación.

4. Corticoides, antibióticos y broncodilatadores:

- **NO recomendados rutinariamente.**
- Pueden considerarse prueba terapéutica única con salbutamol en mayores de 12 meses o con antecedentes de asma.

5. **No utilizar:** adrenalina nebulizada, montelukast, antibióticos (salvo sobreinfección bacteriana).

b. Criterios de hospitalización (MINSAL / IRA)

Hospitalizar si existe:

- SatO_2 <92 % en aire ambiente.
- Apnea, cianosis o signos de dificultad respiratoria grave.
- Imposibilidad de alimentación.
- Edad <3 meses.
- Comorbilidad (cardiopatía, prematurez, inmunodeficiencia).
- Compromiso del estado general o letargia.

Niveles de gravedad:

Grado	SatO_2	Signos clínicos	Manejo
Leve	≥ 95 %	Taquipnea leve, sin retracciones	Ambulatorio
Moderada	90–94 %	Retracciones leves a moderadas	Observación o sala básica
Grave	<90 %	Retracciones intensas, cianosis, apneas	Hospitalización, posible UCI

c. Prevención

1. Medidas generales:

- Lavado de manos.
- Evitar exposición a humo de tabaco.
- Lactancia materna exclusiva.

- Evitar visitas en temporada invernal.

2. Inmunización específica:

- **Vacuna contra virus sincicial respiratorio (RSV):**
 - Incorporada en Chile desde 2024 para **embarazadas (protección pasiva)** y en evaluación para **palivizumab** en grupos de riesgo.
 - **Palivizumab (anticuerpo monoclonal):**
 - Indicado solo en **prematuros <29 sem, cardiopatías congénitas o enfermedades pulmonares crónicas**, con esquema mensual durante la temporada invernal.
-

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- **Apneas recurrentes** (menores de 2 meses).
- **Hipoxemia persistente o acidosis.**
- **Neumonía secundaria (bacteriana).**
- **Deshidratación.**
- **Sibilancias recurrentes post-bronquiolitis** (15–30 %).

b. Pronóstico

- Mortalidad global <1 %.
 - Riesgo elevado en prematuros, cardiópatas o inmunodeprimidos.
 - La mayoría de los lactantes recupera la función pulmonar normal en semanas.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ **Perlas:**

1. La **bronquiolitis es un diagnóstico clínico**, no requiere Rx ni exámenes virales.
2. **VRS** es el agente causal más frecuente ($\approx 80\%$).
3. **Oxígeno suplementario** es el único tratamiento demostrado eficaz.
4. **No usar antibióticos ni corticoides de rutina.**
5. **Criterio de hospitalización principal:** $\text{SatO}_2 < 92\%$ o dificultad respiratoria significativa.
6. **Palivizumab** se usa solo en grupos de alto riesgo.
7. **Vacuna materna RSV (MINSAL 2024)** protege al recién nacido durante los primeros meses.

□ **Errores frecuentes:**

- Indicar broncodilatadores o antibióticos innecesarios.
- Solicitar radiografía en casos leves.
- Omitir hospitalización en lactantes pequeños con hipoxemia.
- No reconocer apneas en RN como signo de gravedad.
- No educar a los padres sobre signos de alarma.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **bronquiolitis** es una infección viral de vías bajas que afecta a **lactantes menores de 2 años**, principalmente por **VRS**.
2. Su diagnóstico es **clínico**, basado en tos, taquipnea y sibilancias tras un cuadro catarral.
3. **Tratamiento de soporte:** oxígeno, hidratación, aspiración nasal y observación.
4. **No usar broncodilatadores, corticoides ni antibióticos de rutina.**

5. **Hospitalizar** si $\text{SatO}_2 < 92\%$, dificultad respiratoria grave o comorbilidad.
6. **Palivizumab** o **vacuna materna RSV** se reservan para grupos de alto riesgo.
7. La mayoría evoluciona bien; las secuelas más comunes son **sibilancias recurrentes**.